

POC



Padronizar nomenclatura em pt-br ou en-us



Não há separação nesse gráfico.

Hospital Indicators

Sistema Hospitalar

Estrutura Hospitalar
Gestão de setores hospitalares

Buscar setor

Setor	Tipo	Status	Ações
Diretoria Médica Coordenação médica	Hospital	Ativo	✎ ✖
UTI Adulto Pacientes críticos	Assistência	Ativo	✎ ✖
TI Tecnologia da informação	Administrativo	Inativo	✎ ✖
Farmacia Medic	Hospital	Ativo	✎ ✖
Farmacia satellite xp10 Sat	Hospital	Ativo	✎ ✖

Necessário permitir criar subcategorias.

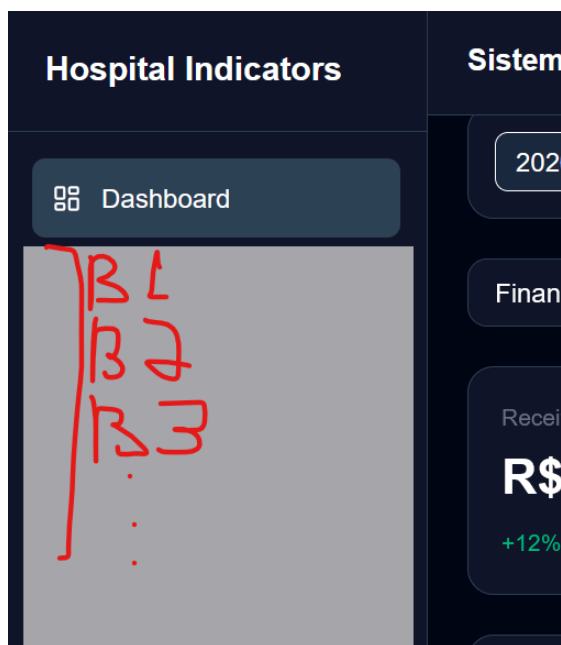
A categoria pai deverá sempre ser o total dela própria mais as filhas.

Ex.: Farmacia tem 20 dipironas, farmácia satélite tem 10, farmácia deverá constar estoque próprio de 20 + 10 (Validar melhor visibilidade).

Separar a parte de dash em “blocos” (verificar nomenclatura com alessandro)

Cada bloco referente a um setor de BI diferente, para a poc, terá no máximo 2 gráficos de curadoria por bloco.

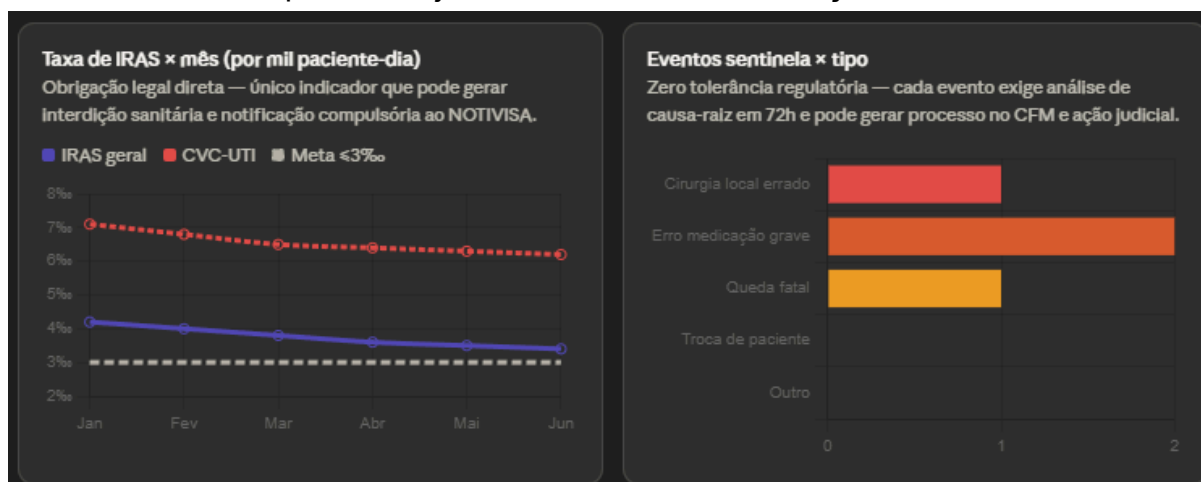
(validar com o alessandro se faz sentido deixar a referência dos indicadores ou não, creio que não é necessário)



Bloco 1 — Segurança do paciente

Taxa de IRAS × mês + Eventos sentinela por tipo.

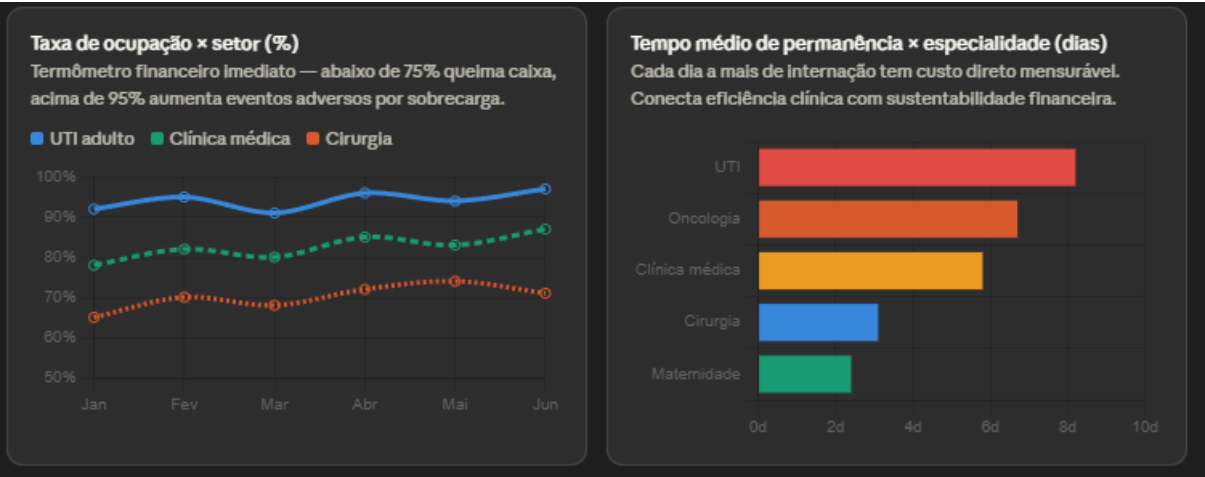
A IRAS é a obrigação legal mais direta (RDC 36/2013 + notificação ao NOTIVISA) é o único indicador que pode gerar interdição sanitária. O evento sentinela é o que nenhum investidor quer ler no jornal — zero tolerância e ação imediata.



Bloco 2 — Eficiência operacional

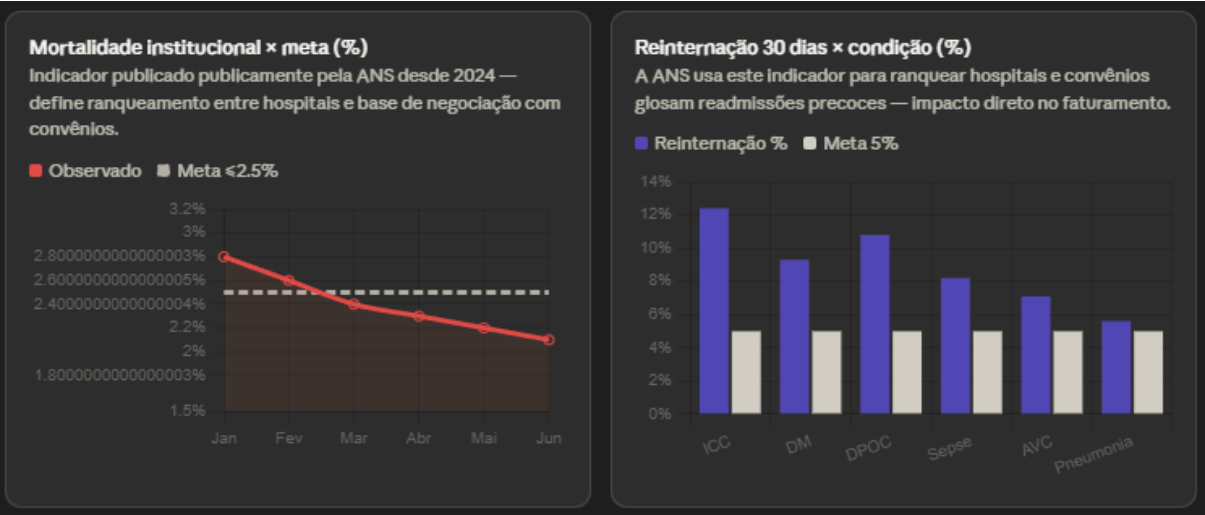
Taxa de ocupação × setor + Tempo médio de permanência × especialidade.

Ocupação é o termômetro financeiro imediato do hospital — abaixo de 75% queima caixa, acima de 95% queima a equipe. TMP é o único indicador que conecta eficiência clínica com custo: cada dia a mais de internação tem custo direto mensurável.



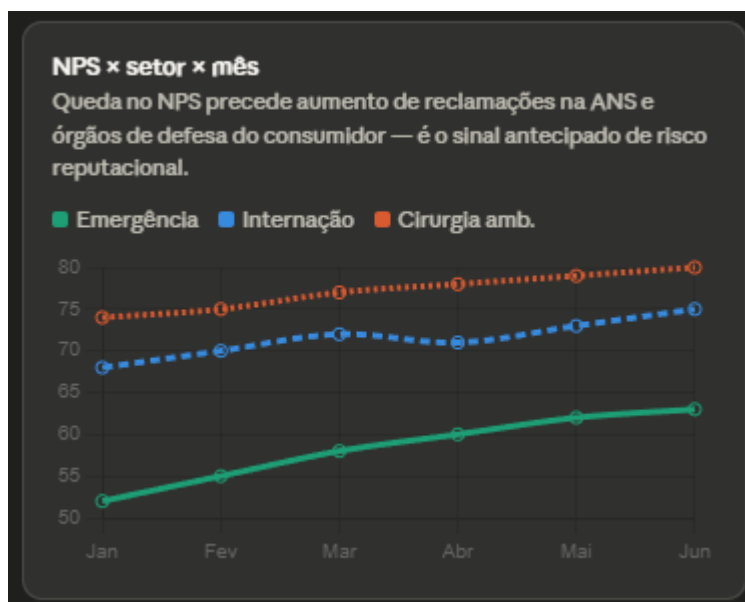
Bloco 3 — Qualidade clínica

Taxa de mortalidade institucional x meta + Taxa de reinternação 30 dias x condição. Mortalidade é o indicador-âncora de qualidade assistencial — é o que a ANS publica publicamente (PM-QUALISS 2024) e o que convênios usam para negociar tabela. Reinternação é o segundo mais impactante: cada readmissão é uma falha de alta que o convênio pode glosar e que o regulador usa para ranquear hospitais.



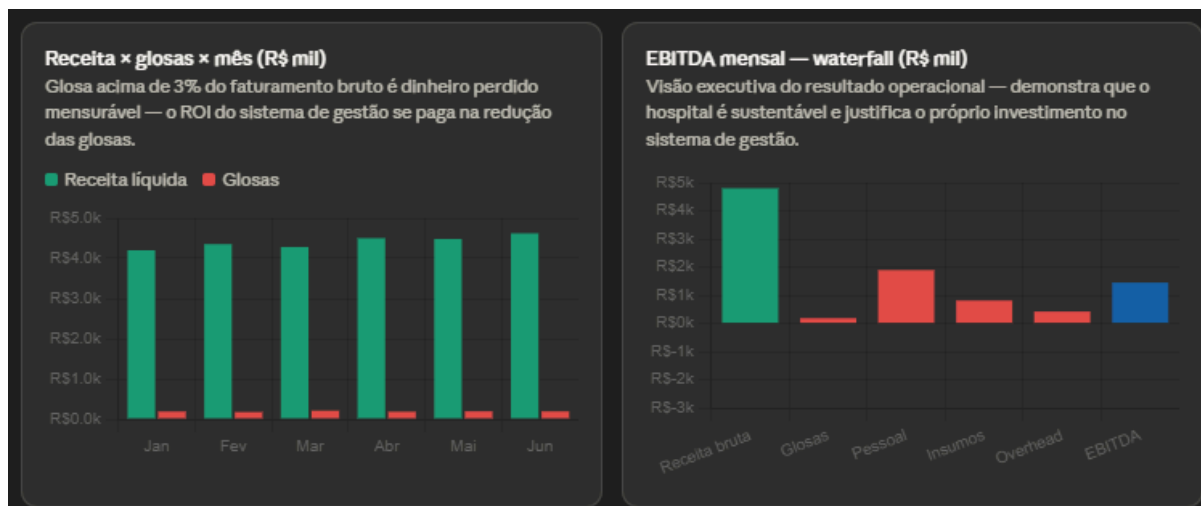
Bloco 4 — Satisfação

Gráfico neste bloco (NPS x setor x mês) porque satisfação em POC precisa de apenas uma pergunta: "estamos melhorando?". O tempo de resposta a chamados é relevante, mas é operacional — entra depois.



Bloco 5 — Financeiro

Receita × glosas × mês + EBITDA waterfall. Glosa é dinheiro perdido mensurável — com percentual e valor absoluto, qualquer executivo entende o ROI do sistema. O waterfall de EBITDA é o fechamento: mostra que o hospital é ou não sustentável e justifica o próprio investimento no sistema.



Doc futuro definitivo:

BLOCO 1 — SEGURANÇA DO PACIENTE

Gráfico 1 — Linha do Tempo: Taxa de IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde) × Mês Monitora a evolução mensal das infecções adquiridas dentro do hospital. É o indicador mais crítico da segurança assistencial. A RDC 36/2013 da ANVISA obriga hospitais a instituírem o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e a monitorarem os seis protocolos básicos de segurança do paciente, com notificação de eventos adversos ao sistema NOTIVISA. O não monitoramento gera obrigação de notificação compulsória e pode resultar em interdição sanitária.

Norma vinculada: RDC ANVISA nº 36/2013 | Portaria MS nº 529/2013 |
Portaria GM/MS nº 2.616/1998

Gráfico 2 — Gauge/Termômetro: Densidade de Infecção em CVC-UTI (por mil cateter-dia)

A densidade de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central em UTI Adulto, medida por mil cateter-dia, é um dos indicadores coletados sistematicamente pela ANAHP como referência nacional de benchmarking hospitalar. É o indicador com maior impacto em mortalidade em UTI e serve como termômetro direto das práticas de higiene e protocolos de bundle.

Norma vinculada: RDC ANVISA nº 36/2013 | Plano ANVISA 2026–2030

Gráfico 3 — Barras Empilhadas: Quedas com Dano ao Paciente × Setor (por mil paciente-dia)

Estratifica em qual setor hospitalar ocorrem mais quedas com lesão. Quedas com dano ao paciente são um dos indicadores do PM-QUALISS Hospitalar da ANS, cujos dados referentes ao ano-base 2024 passaram a ser públicos, representando um marco para a transparência na saúde suplementar brasileira.

Norma vinculada: PM-QUALISS ANS | RDC ANVISA nº 36/2013

Gráfico 4 — Barras: Eventos Sentinela por Tipo × Mês

Eventos sentinela são ocorrências graves que nunca deveriam acontecer — cirurgia em local errado, troca de paciente, óbito por erro de medicação. Cada ocorrência exige análise de causa-raiz e notificação ao NOTIVISA. Um único evento sentinela pode gerar processo no CFM, ação judicial e dano reputacional irreversível.

Norma vinculada: RDC ANVISA nº 36/2013 | Código de Ética Médica CFM

Gráfico 5 — Linha: Taxa de Erro de Medicação com Dano × Mês

A densidade de incidência de erro de medicação com dano ao paciente, medida por mil paciente-dia, passa a integrar o sistema de indicadores da ANAHP a partir de 2026. Erros de medicação estão entre as principais causas de eventos adversos evitáveis no mundo. O monitoramento contínuo permite identificar falhas nos processos de prescrição, dispensação e administração.

Norma vinculada: RDC ANVISA nº 36/2013 | ONA Nível 2 e 3

Gráfico 6 — Área: Incidência de Lesão por Pressão Adquirida no Hospital × Mês

A incidência de pacientes com 18 anos ou mais com lesão por pressão adquirida no hospital integra o sistema de indicadores da ANAHP a partir de 2026, refletindo qualidade dos cuidados de enfermagem e protocolos de mobilização. É um indicador de "never event" (evento que não deveria ocorrer) e impacta diretamente o custo assistencial por prolongar internações.

Norma vinculada: Resolução COFEN nº 543/2017 | ONA

BLOCO 2 — EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Gráfico 7 — Gauge + Histórico: Taxa de Ocupação de Leitos × Setor A taxa de ocupação de leitos pode refletir tanto eficiência quanto gargalos operacionais — abaixo de 75% indica ociosidade financeira; acima de 95% indica risco de sobrecarga assistencial e queda na qualidade. Dashboards que mostram em tempo real a taxa de ocupação permitem redistribuir pacientes, liberar leitos com agilidade e aumentar a eficiência do giro hospitalar, melhorando tanto a experiência do paciente quanto a rentabilidade da instituição.

Norma vinculada: RDC ANVISA nº 50/2002 (dimensionamento de leitos)
| Portaria MS nº 2.395/2011 (UTI)

Gráfico 8 — Linha: Tempo Médio de Permanência (TMP) × Especialidade Clínica O tempo médio de permanência representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados, sendo um dos indicadores centrais do CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar). TMP elevado indica ineficiência de fluxo, atraso em alta, ou complexidade do case-mix. Impacta diretamente o faturamento, giro de leitos e satisfação do paciente.

Norma vinculada: CQH/ANAHP | QUALISS ANS | Portaria MS nº 1.631/2015

Gráfico 9 — Barras: Taxa de Cancelamento Cirúrgico × Motivo Monitora o percentual de cirurgias canceladas após agendamento e estratificação por causa (paciente não preparado, falta de material, falta de equipe, leito UTI indisponível). A taxa de cancelamento cirúrgico é um dos indicadores mais monitorados e exigidos pelas acreditadoras ONA e JCI. O cancelamento tem impacto triplo: financeiro (bloco cirúrgico ocioso), assistencial (piora do quadro do paciente) e regulatório (insatisfação de convênios).

Norma vinculada: ONA Nível 2 | RDC ANVISA nº 15/2012 (materiais cirúrgicos)

Gráfico 10 — Funil: Tempo de Espera na Emergência × Classificação de Risco (Manchester) O tempo de espera na emergência é um dos parâmetros assistenciais monitorados pelo PM-QUALISS Hospitalar da ANS. O Protocolo de Manchester classifica pacientes em 5 cores (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul). O gráfico tipo funil mostra o cumprimento dos tempos-alvo por faixa de risco. Violações nos tempos vermelho e laranja configuram risco de morte evitável.

Norma vinculada: Portaria MS nº 2.048/2002 (regulação da emergência) | CFM nº 2.077/2014

Gráfico 11 — Barras Agrupadas: Giro de Leito × Setor × Mês

O índice de giro de leito mede quantos pacientes deixam os leitos em relação à disponibilidade — quanto maior o giro, maior a produtividade e eficiência do hospital. Comparado entre setores (clínica médica, cirurgia, UTI, maternidade), revela gargalos específicos e oportunidades de otimização de fluxo.

Norma vinculada: CQH | QUALISS ANS

BLOCO 3 — QUALIDADE CLÍNICA E RESULTADOS

Gráfico 12 — Linha com Benchmark: Taxa de Mortalidade Institucional × Mês

A taxa de mortalidade institucional é um dos indicadores centrais do PM-QUALISS Hospitalar da ANS, cujos dados passaram a ser públicos com referência ao ano-base 2024. A Razão de Mortalidade Hospitalar Padronizada (RMHP) — quociente entre mortalidade observada e esperada — corrige diferenças no case-mix dos pacientes e permite comparação justa entre hospitais.

Norma vinculada: PM-QUALISS ANS | ONA | PNASS/Ministério da Saúde

Gráfico 13 — Linha: Taxa de Reinternação em 30 Dias × Condição Clínica

A reinternação é um dos parâmetros assistenciais monitorados pelo programa da ANS. A ANS avalia especificamente o índice de readmissão hospitalar como critério de qualidade assistencial. Reinternações precoces indicam alta prematura, falhas na continuidade do cuidado ou ausência de protocolo de seguimento ambulatorial. Em modelos de value-based care, geram glosas e penalizações de convênios.

Norma vinculada: PM-QUALISS ANS | Resolução ANS nº 558/2022

Gráfico 14 — Taxa de Mortalidade Operatória (até 7 dias) × Tipo de Procedimento

A taxa de mortalidade operatória até 7 dias após procedimento é monitorada pelo sistema de indicadores hospitalares da ANAHP. Permite identificar procedimentos

com mortalidade acima do esperado para o perfil do caso, sinalizando necessidade de revisão de técnica, equipe ou protocolo pré-operatório.

Norma vinculada: CFM (Resolução nº 2.217/2018 – Código de Ética) | ONA Nível 3 | JCI

Gráfico 15 — Scorecard: Taxa de Infecção em Sítio Cirúrgico (ISC) × Tipo de Cirurgia

A taxa de infecção em sítio cirúrgico após cirurgia limpa é um dos indicadores centrais do sistema ANAHP. Cirurgias limpas (sem contato com cavidades) deveriam ter ISC próxima de zero. Taxas elevadas indicam falha na antisepsia, antibioticoprofilaxia ou técnica cirúrgica. É um indicador auditado em processos de acreditação ONA e JCI.

Norma vinculada: ANVISA – Nota Técnica 01/2013 (ISC) | ONA | JCI

BLOCO 4 — SATISFAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

Gráfico 16 — NPS (Net Promoter Score) Hospitalar × Setor × Mês

O NPS do paciente é um dos indicadores mais monitorados e exigidos por acreditadoras ONA e JCI. Mede a lealdade e satisfação geral dividindo pacientes em promotores, neutros e detratores. A visão por setor (emergência, internação, cirurgia ambulatorial) permite ações direcionadas. Queda no NPS frequentemente precede aumento de reclamações em ANS e órgãos de defesa do consumidor.

Norma vinculada: Resolução ANS nº 323/2013 (ouvidoria) | ONA | JCI (Padrão PFR)

Gráfico 17 — Barras: Tempo de Resposta a Chamados de Enfermagem × Turno

Monitora quanto tempo leva entre o acionamento do paciente e o atendimento da enfermagem, estratificado por turno (manhã, tarde, noite). Tempos elevados no noturno indicam subdimensionamento de equipe. Está diretamente ligado à incidência de quedas e eventos adversos não supervisionados.

Norma vinculada: Resolução COFEN nº 543/2017 (dimensionamento de pessoal de enfermagem) | ONA

BLOCO 5 — FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE

Gráfico 18 — Área Empilhada: Receita × Glosas × Mês (por convênio)

A glosa é a recusa de pagamento por parte do convênio por inconsistências no faturamento. Monitora o percentual de faturamento glosado por operadora. O Consórcio de Indicadores de Qualidade Hospitalar da ANS visa auxiliar na avaliação do desempenho das instituições hospitalares privadas através do monitoramento de indicadores que permitem identificar lacunas e boas práticas. Glosas acima de 3% do faturamento bruto indicam falhas sistêmicas em codificação, auditoria interna ou protocolos clínicos.

Norma vinculada: Resolução ANS nº 259/2011 (prazos de pagamento) | Lei nº 9.656/1998

Gráfico 19 — Linha: CMO (Custo Médio por Internação) × TMP × Especialidade

Correlaciona o custo médio de internação com o tempo de permanência por especialidade. Permite identificar quais serviços são estruturalmente deficitários e orientar negociações de tabela com convênios. É fundamental para hospitais que buscam certificação de qualidade com sustentabilidade financeira.

Norma vinculada: ONA (exige planejamento financeiro sustentável) | ANS (contratualização)

Gráfico 20 — Waterfall: EBITDA Hospitalar Mensal (Receita → Deduções → Custos Diretos → EBITDA)

Visão executiva da geração de caixa operacional. O gráfico waterfall mostra cada componente de adição e subtração até chegar ao resultado operacional. Indispensável para o CFO e CEO monitorarem a saúde financeira e planejarem investimentos em infraestrutura e tecnologia.

Norma vinculada: Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.) | NBC TG 00 (CPC) | exigência de auditores ONA Nível 3

BLOCO 6 — RECURSOS HUMANOS E DIMENSIONAMENTO

Gráfico 21 — Mapa de Calor: Absenteísmo da Equipe × Setor × Dia da Semana

O mapa de calor identifica padrões de ausência que criam risco assistencial recorrente (ex: toda segunda-feira na UTI). A dimensão de eficiência mede o uso dos recursos hospitalares, sendo a força de trabalho o principal deles. Absenteísmo crônico acima de 4% gera sobrecarga, burnout e aumento de eventos adversos.

Norma vinculada: Resolução COFEN nº 543/2017 | CLT | NR-32 (saúde do trabalhador em saúde)

Gráfico 22 — Barras: Índice de Turnover × Categoria Profissional

Monitora a rotatividade por categoria (médico, enfermeiro, técnico, administrativo). Turnover de enfermagem acima de 15% ao ano é crítico — impacta a curva de

aprendizado, segurança do paciente e custo de contratação/treinamento.
Acreditoras ONA avaliam estabilidade e capacitação das equipes como critério de maturidade institucional.

Norma vinculada: ONA Nível 2 e 3 | NR-32 | Resolução CFM nº 2.077/2014